

Fecha Última Actualización: 05-06-2024 16:29:20

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Maria Cristina Perez Riquelme
Edad : 68a 3m 19d
Dirección : El Fardo 3877 Villa El Labrador 0

Rut : 7.077.971-4
Fecha Nacto: 17/02/1956
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 9428360
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 4620 5821

N° Epicrisis
401604

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Ingreso : 24/05/2024 19:44

Días Estadía: 12

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 05/06/2024 16:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

COMENTARIO DE INGRESO A UCI

Nombre: María Cristina Pérez Riquelme
RUT: 7077971-4
Edad: 68 años
FI HSR: 24/05/24
FI SALA: 25/05/24
FI UTIM: 28/05/24
FI UCI: 29/05/24

ANAMNESIS REMOTA

·Médicos: ICC valvular (EcoTT 02/24 FeVlp, tricúscipe normofuncionante), Hipotiroidismo, Usuaria Marcapasos, FA en NACO, Hipertensión Pulmonar, CNG agosto 2023 sin lesiones, ERC IIIa-IIIb
·Quirúrgicos: CIA operada (1987) shunt residual de derecha a izquierda, recambio valvular tricúspide con prótesis biológica (2016), TAVI tricúspideo enero 2024
·Fármacos: Bisoprolol 5mg/día, Amiodarona 200 mg/día, Atorvastatina 20 mg, Furosemida 40-40 mg, Espironolactona 12,5 mg, Apixaban 2,5 mg c/12 hrs, Ácido Fólico 5mg, Omeprazol 20 mg, Eutirox 50 mcg, Empaglifozina 12,5 mg
·Alergias: no refiere
·Hábitos: TBQ (-), OH (-), Drogas (-)
·Hospitalizaciones recientes: 07 al 12/05 por ICC descompensada
·Inmunizaciones: COVID 19 5 dosis, Influenza 2014 (-)
·Sociales: Autovalente, dueña de casa, vive con marido e hija (Jocelyn 972279181) (hija Elizabeth 946205821)

ANAMNESIS PRÓXIMA

Paciente con antecedentes descritos, destaca antecedentes de cardiopatía valvular + CIA, con recambio valvular tricúspideo con disfunción de prótesis en enero 2023 por estenosis severa + insuficiencia moderada. En esta hospitalización ingresó por ICC descompensada patrón tibio húmedo, requirió terapia depleitiva, cambio de modalidad de VVI a DDD con retorno a RS, requirió TAVI tricúspideo 23/01/24 con sondeo derecho compatible con HT pulmonar post capilar aislada. Además Crea basal entre 0.8-1.25 con ERC 3A-3B interpretado en contexto de SCR tipo 1. Además con anemia microcítica ferropriva y pancitopenia, requirió carga 5/5 de hierro interpretado en contexto de daño hepático congestivo.

Fecha Epicrisis : 05/06/2024 16:29

Página 1 de 3

Desde enero con deterioro progresivo de capacidad funcional, llegando hasta mínimos esfuerzos, consulta por 1 semana de evolución de disnea en reposo, edema de extremidades inferiores y alza de peso de 2 kg. Ingres a al servicio de urgencia en regulares condiciones, taquicárdica (117), hipotensa (89/51) y subfebril hasta 37,5°C, saturando 93% con 2 litros de oxígeno por naricera. En sus exámenes de ingreso destaca PI ligeramente elevados con anemia normocítica y trombocitopenia (PCR 11.6 Leu:5.45 Hb:10.7 Pla:140.000) AKI KDIGO III (Crea:3.24 BUN:52 Na:143 K:4.33 Cl:107) TUS 65.4, perfil hepático colestásico (BT:1.04 FA:182 GGT:149 GOT:37 GPT:33) Láctico:15.3, coagulopatía INR:4.04 TTPK.40.1.

Inicialmente ingresa a sala, en donde se maneja como ICC patrón húmedo-caliente, se indicó terapia depletiva, inicialmente con adecuada respuesta. El 28/05 evoluciona con insuficiencia respiratoria, hipotensión, aumento requerimientos de O₂ hasta 3 lts por NRC, taquipnea y subfebril con aumento de PI. Se pancultiva, se toma panel viral positivo para Influenza A. Se indica 250 cc de SF, NBZ con berodual, hidrocortisona 100 mg y se conecta a CNAF Fio₂

50%. En este contexto se traslada a UTIM.

En UTIM evoluciona con progresión de insuficiencia respiratoria que motiva intubación y conexión a VMI en menos de 24 horas, shock profundo refractario con intensa acidosis metabólica se invade con CVC y CHD y se solicita HFVVC. Se traslada a UCI para continuar manejo.

IMÁGENES

- TAC de tórax con contraste (24/05/24): Acentuada cardiomegalia global. Aumento de calibre del tronco de la arteria pulmonar, podría corresponder a signo de hipertensión pulmonar. Signos de edema pulmonar intersticial y alveolar. Leve derrame pleural derecho con componente cistural. Cambios edematosos del plano subcutáneo. Ascitis.

- Ecocardiograma 2024: Prótesis percutánea (Valve-In-Valve) normofuncionante. Ventrículo izquierdo levemente dilatado, con función sistólica global y segmentaria conservada. Llenado tipo II. Aurícula izquierda severamente dilatada. Insuficiencia mitral moderada de origen mixto. Cavidades derechas dilatadas, con función sistólica del VD disminuida. Signos de hipertensión pulmonar.

- Ecografía R enal (08/05/24): signos ecográficos de nefropatía medica bilateral, leve ascitis perihepática y periesplénica.

INGRESO A UCI

1.Hemodinamia/CV: Acidosis láctica con shock refractario Epinefrina a 0.6, NAD 1.0 y Vasopresina 0.06 UI/min lactato en 51 se conecta a HFVVC con aporte de 200 ml de albúmina.

2.Respiratorio: no es descartable SDRA aunque tiene proBNP > 70.000 se conecta a VMI en modalidad protectora, sedación para SAS 1 primera PaFi > 200 con Fio₂ al 75% hiperoxémico. Cestat 14 DP 20. Impresiona pulmón rígido, pero no es dependiente de PEEP. De momento sin BNM.

3.Renal: ERC etapa III, ingresa con falla renal aguda, probable nefrosarcoma vs Sx cardiorenal tipo 1. Actualmente oligúrica por shock, sin respuesta a prueba de furosemida, Se indica HFVVC procurar BH negativo una vez condición hemodinámica lo permita me impresiona principal conflicto de momento.

4.Infeccioso: Síndrome febril, con neumonía multilobar por Influenza A recibiendo Oseltamivir. Hay elementos para pensar en sobreinfección que dado contexto intrahospitalario intermitente, con neutropenia y shock profundo se escala a Tazonam, se adiciona vancomicina al ingreso, solicito CAET de obtener muestra, de lo contrario considerar LBA.

5.Hematológico: Antecedente de bicitopenia, por anemia microcítica ferropénica y trombocitopenia, interpretada en contexto de hepatopatía congestiva, por el momento mantener seguimiento, metas transfusionales permisivas, vigilancia de exteriorización de sangrado. No es factible plantear anticoagulación dada HFVVC y Sd urémico.

6.Profilaxis: IBP + HFN en circuito de HFVVC

7.No esta en condiciones de recibir nutrición aun.

Evolución en UCI

Deterioro hemodinámico inicialmente solventado con HFVVC logra BH negativo pero y disminución de DVAs pero sin llegar a suspender.

Disfunción renal que se mantiene con TRR intermitente

En lo respiratorio inicialmente sin tanto conflicto de intercambio pero progresa en rigidez y elevación de DP con caída de intercambio por lo que se prona por 72 horas se supina con mejoría del intercambio pero 24 horas despues nuevamenta caída de PaFi < 150 se reinicia BNM y se mantiene con mecánica injuriosa y DP > 15 Fio₂ 50% no es factible plantear destete

El día de hoy mayor compromiso HDN por lo que se desestima HD

Progresa en DOM pese a todos los soportes fallece a las 15:10 horas del 05.06.24

Diagnóstico de Egreso

Fecha Epicrisis : 05/06/2024 16:29

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 05-06-2024 16:29:20

Página 3 de 3

Choque séptico -

1. Shock Mixto séptico/cardiogénico refractario
 - 1.1 Neumonía multilobar por Influenza A sobreinfectada
2. Insuficiencia respiratoria aguda
 - 2.1 Edema pulmonar agudo
3. Insuficiencia cardíaca valvular descompensada patrón frío-húmedo
4. Antecedentes

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallecido

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Juan Giraldo Paramo

Médico Tratante (Staff)